

TROMBOCITOPENIA INMUNE PRIMARIA

Irene Padilla Conejo, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

- La Trombocitopenia Inmune Primaria (PTI) es una enfermedad autoinmune caracterizada por una disminución del número de plaquetas por debajo de **100000/ μ l**. Puede ser primaria (ausencia de desencadenante conocido) o secundaria (asociada a enfermedades virales, autoinmunes y algunos fármacos)
- Se debe a la producción de **autoanticuerpos antiplaquetarios IgG** dirigidos contra antígenos de la membrana plaquetaria (GPIIb/IIIa), que se unen a las plaquetas y sus precursores, produciendo tanto una disminución de la producción como un aumento de la destrucción.
- Incidencia: 1/10000. **Causa más común de trombocitopenia** en la práctica clínica
- Puede aparecer a **cualquier edad**. En niños, la máxima incidencia está entre los 3 y 5 años; afectando por igual a ambos sexos. En adultos es más frecuente en mujeres entre la 2ª-3ª década de la vida.

CLÍNICA

Síndrome hemorrágico de pocos días de evolución, en el que pueden aparecer:

- **Lesiones purpúricas**: petequias y equimosis. Presentes en la mayoría de los casos.
- **Hemorragias mucosas**: epistaxis, gingivorragia, hematuria, menorragia, melenas. En menor frecuencia que los anteriores
- **Hemorragia intracraneal**: muy rara.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la PTI es un diagnóstico de exclusión



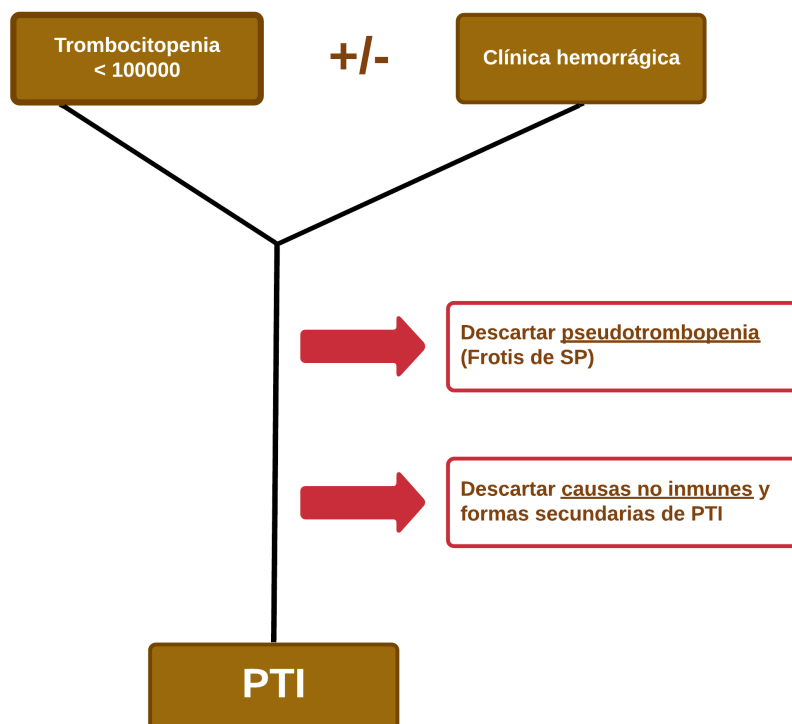
En Urgencias, ante sospecha de PTI se debe solicitar:

- Historia clínica: características de la hemorragia (gravedad, extensión y tiempo de evolución). La exploración física, salvo las lesiones purpúricas, suele ser normal.
- Hemograma con reticulocitos: generalmente trombocitopenia aislada. Puede encontrarse anemia o ferropenia en relación a la cantidad y duración de la hemorragia.
- Frotis de sangre periférica: descartar pseudotrombocitopenia por EDTA, satelismo plaquetario o procesos microangiopáticos.
- Coombs directo: negativo.
- Coagulación.
- Bioquímica general con perfil hepático, LDH y PCR.

Trombocitopenia no inmune	Trombocitopenia inmune
Producción disminuida de plaquetas (enfermedades hematológicas, fármacos, deficiencia nutricional)	Enfermedades autoinmunes (LES, SAF, enfermedad inflamatoria intestinal...)

Trombocitopenia no inmune	Trombocitopenia inmune
Destrucción/consumo aumentado de plaquetas (hiperesplenismo, CID, infección)	Inducida por fármacos (heparina, vancomicina, quinidina...)
Trombocitopenias congénitas	Infección por VIH, VHC, Helicobacter pylori
	Síndromes linfoproliferativos
	Trombocitopenia aloinmune
	Vacunación reciente
	Púrpura postransfusional

- Descartar causas de trombocitopenia no autoinmune y de formas secundarias de PTI:



TRATAMIENTO

Objetivo

Mantener cifra de plaquetas en un nivel seguro para evitar posible hemorragia.

Criterios De Inicio De Tratamiento

Plaquetas	Criterios inicio tratamiento
<20-30x10 ⁹ /L	Tratamiento independientemente de la presencia de hemorragia
≥ 20-30 y <50x10 ⁹ /L	Tratamiento cuando existe hemorragia
≥ 50x10 ⁹ /L	En general no está indicado tratamiento. Descartar otras posibles causas de hemorragia.

Tratamiento En Urgencias

- Control de la tensión arterial
- Minimizar el riesgo traumático
- Interrumpir fármacos que alteren la función plaquetaria y anticoagulantes
- Iniciar el tratamiento de 1º línea (Corticoides IV y/o Inmunoglobulinas IV a altas dosis)
- Transfusión de plaquetas: sólo en caso de hemorragia grave o que ponga en peligro la vida

NOTA

- Ante paciente con trombopenia de reciente aparición de $<10 \times 10^9/L$, debemos pensar en PTI tras descartar pseudotrombopenia y otras causas de trombopenia no inmune.

BIBLIOGRAFÍA

- Sanz M, Carreras E. Manual Práctico de Hematología Clínica 2014, 5º edición.
- Guía Práctica Clínica para la PTI en Castilla y León. Documento de consenso. Sociedad Castellano-Leonesa de Hematología y Hemoterapia.